

1. Acid–Base Imbalance & ABG Interpretation

Classification / Types

Q1. What are the three body systems that keep acid–base balance?

ما الأنظمة الثلاثة في الجسم المسؤولة عن الحفاظ على توازن الحمض والقلوي؟

Answer: Blood buffers, lungs, kidneys.

أنظمة الدم، الرئتين، الكلى: الإجابة

Q2. What are the four main acid–base disorders?

ما الاضطرابات الأربعة الأساسية للحمض والقلوي؟

Answer: Respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, metabolic alkalosis.

حماض تنفسي، قلاء تنفسي، حماض أيضي، قلاء أيضي: الإجابة

Definition / Physiology

Q3. How does the body reduce acid in metabolic acidosis through breathing?

كيف يقلل الجسم الحموضة في الحماض الأيضي عن طريق التنفس؟

Answer: By increasing breathing to remove more CO₂.

بزيادة معدل التنفس لطرد ثاني أكسيد الكربون: الإجابة

Q4. What happens to bicarbonate level in metabolic alkalosis?

ماذا يحدث لمستوى البيكربونات في القلاء الأيضي؟

Answer: It increases above normal (> 26 mEq/L).

يرتفع عن الطبيعي (أكثر من 26): الإجابة

Causes

Q5. What two acute causes can stop or slow breathing and cause respiratory acidosis?

ما سببين حادين يبطئوا التنفس ويؤدوا لحماض تنفسي؟

Answer: Sedative/anesthetic drugs, cardiac arrest.

أدوية مخدرة أو مهدئة، توقف القلب: الإجابة

Q6. How can bicarbonate be lost causing metabolic acidosis? (two causes)

كيف تفقد البيكربونات وتسبب حماض أيضي؟ (سببين)

Answer: Diarrhea, kidney problems.

الإسهال، مشاكل الكلى: الإجابة

Q7. What two common causes lead to metabolic alkalosis?

ما سببين شائعين يؤديان لقلع أيضي؟

Answer: Severe vomiting, excessive antacid use.

القيء الشديد، الإفراط في مضادات الحموضة: الإجابة

Clinical Manifestation

Q8. What early brain symptoms appear in respiratory acidosis? (three)

ما الأعراض العصبية المبكرة في الحماض التنفسي؟ (ثلاثة)

Answer: Headache, blurred vision, restlessness.

صداع، زغللة، قلق أو تملل: الإجابة

Q9. What heart problems happen when pH is very low in respiratory acidosis? (two)

بشدة في الحماض التنفسي؟ (اثنين) pH ما المشاكل القلبية عند انخفاض الـ

Answer: Arrhythmias, low blood pressure.

اضطراب ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم: الإجابة

Q10. What are common symptoms of respiratory alkalosis? (three)

ما الأعراض الشائعة للقلع التنفسي؟ (ثلاثة)

Answer: Fast breathing, dizziness, tingling of hands or arms.

سرعة التنفس، دوخة، تنميل في الأطراف: الإجابة

Diagnostic Test

Q11. What pH value shows acidosis and alkalosis?

التي تدل على الحموضة والقلوية؟ pH ما قيمة الـ

Answer: $< 7.35 = \text{acidosis}$, $> 7.45 = \text{alkalosis}$.

أقل من 7.35 حموضة، أكثر من 7.45 قلوية: الإجابة

Q12. What are the basic steps to read an ABG? (four)

ما الخطوات الأساسية لقراءة غازات الدم؟ (أربعة)

Answer: Check oxygen, check pH, find main problem, check compensation.

، تحديد المشكلة الأساسية، تقييم التعويض pH تقييم الأكسجين، تقييم: الإجابة

Q13. What ABG values indicate respiratory acidosis?

التي تدل على حمض تنفسي؟ ABG ما نتائج

Answer: Low pH, high CO_2 , normal bicarbonate.

مرتفع، بيكربونات طبيعية CO_2 منخفض، pH: الإجابة

Management

Q14. What is the first treatment for severe respiratory acidosis?

ما أول علاج في الحمض التنفسي الشديد؟

Answer: Open airway and give mechanical ventilation if needed.

فتح مجرى الهواء واستخدام جهاز تنفس صناعي عند الحاجة: الإجابة

Q15. How is respiratory alkalosis from anxiety treated without drugs?

كيف يُعالج القلاء التنفسي الناتج عن القلق بدون أدوية؟

Answer: Paper bag breathing and reassurance.

التنفس في كيس ورقي وطمأنة المريض: الإجابة



Module 3: Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Definition

Q1. What is ARDS?

ما هو ARDS؟

Answer: A severe lung condition with fluid in both lungs causing low oxygen.

حالة خطيرة يحدث فيها تجمع سوائل بالرئتين مما يسبب نقص الأكسجين: الإجابة

Causes

Q2. What are direct lung causes of ARDS? (three)

المباشرة من الرئة؟ (ثلاثة) ARDS ما أسباب

Answer: Pneumonia, aspiration, chest trauma.

الالتهاب الرئوي، شطف محتويات المعدة، إصابة الصدر: الإجابة

Q3. What are indirect causes of ARDS? (three)

؟ (ثلاثة) ARDS ما الأسباب غير المباشرة لـ

Answer: Sepsis, severe trauma with shock, acute pancreatitis.

تعفن الدم، صدمة شديدة، التهاب البنكرياس الحاد: الإجابة

Clinical Manifestation

Q4. What are common signs of ARDS? (four)

؟ (أربعة) ARDS ما العلامات الشائعة لـ

Answer: Dyspnea, tachypnea, tachycardia, cyanosis.

ضيق نفس، سرعة تنفس، سرعة ضربات القلب، زرقة: الإجابة

Q5. Why can mechanical ventilation cause pneumothorax in ARDS?

ARDS؟ لماذا قد يسبب جهاز التنفس الصناعي استرواح الصدر في

Answer: High pressure damages stiff lungs causing air leaks.

الضغط العالي يسبب تمزق الرئة الصلبة وتسرب الهواء: الإجابة

Diagnostic Test

Q6. What does chest X-ray show in ARDS?

ARDS؟ ماذا يظهر أشعة الصدر في

Answer: Bilateral lung infiltrates and fluid.

ارتشاحات وسوائل في الرئتين: الإجابة

Q7. What ABG finding is typical in ARDS?

ABG؟ ما النتيجة المميزة في

Answer: Low oxygen level.

نقص الأكسجين في الدم: الإجابة

Management

Q8. What drugs are used in ARDS? (three)

؟ (ثلاثة) ARDS ما الأدوية المستخدمة في

Answer: Diuretics, steroids, H2 blockers/PPIs.

مدرات البول، الكورتيزون، أدوية تقليل حموضة المعدة: الإجابة

Q9. Why are neuromuscular blockers used in ventilated ARDS patients?

لماذا تُستخدم مرخيّات العضلات؟

Answer: To prevent fighting the ventilator and rest muscles.

لمنع مقاومة الجهاز وإراحة عضلات التنفس: الإجابة



Module 4: ECG Interpretation

Definition / Physiology

Q1. What does each ECG wave represent?

ECG؟ ماذا تمثل موجات

Answer: P: atrial depolarization, QRS: ventricular depolarization, T: ventricular repolarization.

الإجابة:

P: انقباض الأذنين

QRS: انقباض البطين

T: عودة البطين لوضعه الطبيعي

Q2. What is the isoelectric line?

ما هو الخط المتعادل؟

Answer: Flat baseline of ECG.

الخط المستقيم الأساسي في التخطيط: الإجابة

Diagnostic Test

Q3. What time does one large ECG box represent?

ECG؟ كم يمثل المربع الكبير في

Answer: 0.20 second.

ثانية 0.20: الإجابة

Q4. What is normal PR interval?

PR؟ ما المعدل الطبيعي لـ

Answer: 0.12 – 0.20 second.

من 0.12 إلى 0.20 ثانية: الإجابة

Q5. What is normal QRS duration?

QRS؟ ما المعدل الطبيعي لـ

Answer: 0.06 – 0.10 second.

من 0.06 إلى 0.10 ثانية: الإجابة

Q6. How is heart rate calculated in regular rhythm?

كيف نحسب النبض في النظم المنتظم؟

Answer: $300 \div \text{number of large boxes}$.

عدد المربعات الكبيرة $\div 300$: الإجابة

Q7. How is heart rate calculated in irregular rhythm?

كيف نحسب النبض في النظم غير المنتظم؟

Answer: Count R waves in 6 seconds $\times 10$.

في 6 ثواني $\times 10$ R عدد: الإجابة

✅ Module 5: Lung Injury & Chest Trauma

Definition

Q1. What is flail chest?

Flail chest؟ ما هو

Answer: Three or more ribs broken in two places.

كسر ثلاث ضلوع أو أكثر في مكانين: الإجابة

Q2. Difference between pneumothorax and hemothorax?

Pneumothorax و Hemothorax؟ ما الفرق بين

Answer: Air vs blood in pleural space.

هواء مقابل دم في التجويف البلوري: الإجابة

Q3. What is cardiac tamponade?

Cardiac tamponade؟ ما هو

Answer: Fluid compressing the heart in pericardium.

تجمع سوائل يضغط على القلب: الإجابة

Types

Q4. Types of pneumothorax?

Pneumothorax أنواع

Answer: Simple, traumatic, open, tension.

بسيط، إصابي، مفتوح، ضاغط: الإجابة

Q5. What causes penetrating chest trauma?

ما سبب إصابة الصدر النافذة؟

Answer: Penetration by knife or bullet.

اختراق الصدر بسكين أو رصاصة: الإجابة

Clinical Manifestation

Q6. Main sign of flail chest?

Flail chest؟ العلامة المميزة لـ

Answer: Paradoxical chest movement.

حركة عكسية للصدر: الإجابة

Q7. What is Beck's triad?

Beck؟ ما ثلاثية

Answer: JVD, muffled heart sounds, hypotension.

امتلاء أوردة الرقبة، خفوت صوت القلب، انخفاض الضغط: الإجابة

Q8. Signs of massive hemothorax?

الشديد؟ Hemothorax علامات

Answer: Shock, absent breath sounds.

صدمة، غياب صوت التنفس: الإجابة

Diagnostic Test

Q9. Chest X-ray findings in chest trauma?

الصدر؟ X-ray ماذا يظهر

Answer: Air/fluid, fractures.

هواء أو سوائل، كسور: الإجابة

Management / Goals

Q10. Goal of pneumothorax/hemothorax treatment?

هدف العلاج؟

Answer: Remove air or blood.

إخراج الهواء أو الدم: الإجابة

Q11. Immediate treatment goal of cardiac tamponade?

هدف العلاج الفوري؟

Answer: Remove pericardial fluid.

سحب السائل من التامور: الإجابة

 Module 6: Myocardial Infarction (MI)

Definition

Q1. What is a myocardial infarction (MI)?

ما هو احتشاء عضلة القلب؟

Answer: Death of heart muscle cells due to blocked blood flow.

موت خلايا القلب بسبب انسداد الدم: الإجابة

Causes

Q2. Main disease causing most MIs?

ما MI؟ ما المرض المسؤول عن معظم

Answer: Atherosclerosis (narrowing arteries).

تصلب الشرايين (تضييق الأوعية): الإجابة

Q3. Three main risk factors for MI?

ما ثلاثة عوامل خطر رئيسية؟

Answer: Smoking, high blood pressure, diabetes.

التدخين، ارتفاع ضغط الدم، السكري: الإجابة

Classification / Types

Q4. Three zones after MI?

ما MI؟ ما هي الثلاث مناطق بعد

Answer: Ischemia, injury, infarction.

نقص التروية، الإصابة، الاحتشاء: الإجابة

Q5. Transmural infarction affects which layers?

ما الطبقات المتأثرة في احتشاء كامل الجدار؟

Answer: Endocardium, myocardium, epicardium.

بطانة القلب، عضلة القلب، الغشاء الخارجي: الإجابة

Q6. Artery causing anterior wall MI?

أي شريان يسبب احتشاء الجدار الأمامي؟

Answer: Left anterior descending artery.

الشريان الأمامي النازل الأيسر: الإجابة

Clinical Manifestation

Q7. Chest pain in MI?

MI؟ كيف يكون ألم الصدر في

Answer: Severe, crushing, tight, not related to breathing.

شديد، ضاغط، غير مرتبط بالتنفس: الإجابة

Q8. Physical signs in MI? (skin & vitals)

ما العلامات الجسدية؟ (الجلد والضغط)

Answer: Cool, pale, sweaty skin; low blood pressure or arrhythmia.

الجلد بارد وشاحب ومتعرق؛ انخفاض الضغط أو اضطراب ضربات القلب: الإجابة

Diagnostic Test

Q9. Classic ECG changes in MI?

ECG؟ التغيرات الكلاسيكية في

Answer: ST elevation, inverted T wave, pathological Q wave.

مرضية Q معكوسة، موجة T، ST ارتفاع: الإجابة

Q10. Enzyme released after MI?

MI؟ أي إنزيم يُفرز بعد

Answer: Troponins (cTnI, cTnT).

التروبونين (cTnI ، cTnT): الإجابة

Management

Q11. Pain relief in MI?

MI مسكن ألم في

Answer: Morphine reduces pain and heart workload.

مورفين يقلل الألم ويخفف عمل القلب: الإجابة

Q12. Criteria for fibrinolytic therapy?

متى نبدأ العلاج المذيب للجلطة؟

Answer: Within 6 hours, ST elevation or new LBBB, chest pain > 30 min not relieved by nitrate.

دقيقة لا يزول بالنترات >30 أو فرط الحزمة اليسرى، ألم صدر ST خلال 6 ساعات، ارتفاع: الإجابة



Module 7: Pain Management

Definition

Q1. What is pain?

ما هو الألم؟

Answer: Unpleasant feeling with tissue damage.

إحساس غير مريح مع تلف الأنسجة: الإجابة

Classification / Types

Q2. Four types of pain?

ما أنواع الألم الأربعة؟

Answer: Acute, chronic, nociceptive, neuropathic.

حاد، مزمن، استثناعي، عصبي: الإجابة

Q3. Difference between acute and chronic pain?

الفرق بين الحاد والمزمن؟

Answer: Acute < 6 months; chronic > 6 months.

الحاد أقل من 6 أشهر، المزمن أكثر من 6 أشهر: الإجابة

Physiology

Q4. Four steps in pain process?

أربع خطوات للألم؟

Answer: Transduction, transmission, perception, modulation.

التحويل، النقل، الإدراك، التعديل: الإجابة

Assessment & Diagnosis

Q5. Best measure for pain?

أفضل طريقة لتقييم الألم؟

Answer: Patient's report.

تقرير المريض نفسه: الإجابة

Q6. If patient cannot report pain?

إذا المريض لا يستطيع التقييم؟

Answer: Observe behavior and subjective signs.

الملاحظة والسلوكيات والأعراض: الإجابة

Q7. BPS score indicating pain?

لألم؟ BPS درجة

Answer: > 5.

أكبر من 5: الإجابة

Management

Q8. First-line pain drug?

أول خيار دوائي؟

Answer: Opioid agonists.

أفيونات: الإجابة

Q9. Preferred opioid in unstable patients?

المفضل للمريض غير المستقر؟

Answer: Fentanyl (fast, short-acting).

فينتانيل (سريع المفعول وقصير): الإجابة

Q10. Non-drug techniques?

طرق غير دوائية؟

Answer: Ice, massage.

كمادات ثلج، تدليك: الإجابة



Module 8: Pulmonary Embolism (PE)

Definition

Q1. What is PE?

PE ما هو

Answer: Clot blocks blood flow to lungs.

جلطة تسد تدفق الدم للرئتين: الإجابة

Etiology

Q2. Virchow's triad?

Virchow ثلاثية؟

Answer: Hypercoagulability, vessel injury, venous stasis.

زيادة تجلط، إصابة الأوعية، ركود الدم: الإجابة

Q3. Non-thrombotic emboli?

انسدادات غير الجلطية؟

Answer: Fat, tumor, amniotic fluid.

دهون، أورام، سائل أمنيوسي: الإجابة

Pathophysiology

Q4. Main heart effect of PE?

على القلب؟ PE أثر

Answer: Pulmonary hypertension → right heart strain.

ارتفاع ضغط الرئة → إرهاق القلب الأيمن: الإجابة

Q5. Term for ventilated but not perfused lung?

مصطلح الرئة المتهوأة بلا تدفق دم؟

Answer: Wasted ventilation.

تهوية مهدورة: الإجابة

Clinical Manifestation

Q6. Common PE symptoms? (four)

الشائعة؟ (أربعة) أعراض PE

Answer: Tachycardia, tachypnea, dyspnea, pleuritic chest pain.

سرعة ضربات القلب، سرعة التنفس، ضيق النفس، ألم صدري جانبي: الإجابة

Diagnostic Test

Q7. ECG finding in PE?

نتيجة ECG؟

Answer: Sinus tachycardia.

تسرع الجيب: الإجابة

Q8. ABG in PE?

نتيجة ABG؟

Answer: Low O₂, high pH.

pH. نقص أكسجين، ارتفاع: الإجابة

Q9. Chest X-ray signs in PE? (two)

أشعة صدرية؟ (اثنين)

Answer: Palla's sign, Hampton's hump.

توسع الشريان الرئوي، كتلة شكل إسفين: الإجابة

Management / Goals

Q10. PE management strategies?

استراتيجيات العلاج؟

Answer: Prevention, treatment.

الوقاية، العلاج: الإجابة

Q11. Role of heparin?

دور الهيبارين؟

Answer: Prevent new clots.

يمنع تكون جلطات جديدة: الإجابة

Module 9: Respiratory Failure

Definition

Q1. What is respiratory failure?

ما هو فشل التنفس؟

Answer: Lungs cannot exchange gases well.

الرئتان لا تضمن تبادل غازات كافٍ: الإجابة

Classification

Q2. Type I ABG?

ABG النوع الأول؟

Answer: Low O₂, normal CO₂.

طبيعي CO₂ أكسجين منخفض، :الإجابة

Q3. Type II ABG?

ABG النوع الثاني

Answer: Low O₂, high CO₂, pH ≤ 7.30.

pH ≤ 7.30 مرتفع، CO₂ أكسجين منخفض، :الإجابة

Causes / Etiology

Q4. Two extra-pulmonary causes?

سببان خارج الرئة؟

Answer: Obesity, chest trauma; pleural effusion, pneumothorax.

السمنة، إصابة الصدر؛ انصباب بلوري، استرواح الصدر :الإجابة

Q5. Three main causes of hypoxemia?

ثلاثة أسباب نقص الأكسجين؟

Answer: Hypoventilation, V/Q mismatch, shunt.

نقص التهوية، اختلال التهوية/التروية، تحويلة دم :الإجابة

Pathophysiology

Q6. Effect of low oxygen on cells?

أثر نقص الأكسجين على الخلايا؟

Answer: Tissue damage, lactic acidosis.

تلف الأنسجة وحموضة اللاكتات :الإجابة

Clinical Manifestation

Q7. CNS symptoms? (three)

أعراض الدماغ؟ (ثلاثة)

Answer: Restlessness, agitation, confusion.

تململ، قلق، ارتباك :الإجابة

Q8. Pulmonary symptoms? (two)

أعراض رئوية؟ (اثنين)

Answer: Rapid breathing, use of accessory muscles.

سرعة التنفس، استخدام عضلات إضافية: الإجابة

Management / Goals

Q9. Goals of ARF management? (three)

؟ (ثلاثة) أهداف إدارة ARF

Answer: Fix cause, improve gas exchange, correct acidosis.

علاج السبب، تحسين تبادل الغازات، تصحيح الحمض: الإجابة

Q10. When is invasive ventilation needed?

متى التنفس الصناعي الغير مختصر؟

Answer: $\text{pH} < 7.25$.

$\text{pH} < 7.25$ إذا كان: الإجابة

Q11. Why oxygen + ventilation fixes acidosis?

لماذا يصحح الأكسجين + التنفس الحمض؟

Answer: Body compensates once oxygenated and ventilated.

الجسم يصحح الحمض بعد تهوية وإكسجة كافية: الإجابة



Module 10: Shock Syndrome

Definition

Q1. What is shock at tissue level?

ما هو الصدمة على مستوى الأنسجة؟

Answer: Poor blood flow to tissues.

ضعف تدفق الدم للأنسجة: الإجابة

Types / Classification

Q2. Four main types of shock?

ما هي أنواع الصدمة الأربعة؟

Answer: Hypovolemic, Cardiogenic, Distributive, Obstructive.

نقص حجم الدم، قلبي المنشأ، توزيعي، انسدادى: الإجابة

Q3. Three subtypes of distributive shock?

ما هي الأنواع الفرعية للصدمة التوزيعية؟

Answer: Septic, anaphylactic, neurogenic.

صدمة إنتانية، تحسسية، عصبية المنشأ: الإجابة

Pathophysiology

Q4. What happens in initial stage of shock?

ماذا يحدث في المرحلة الأولية؟

Answer: Cells switch to anaerobic → lactic acid.

الخلايا تعمل بدون أكسجين → حمض لكتيكي: الإجابة

Q5. SNS responses in compensatory stage?

استجابات الجهاز العصبي في المرحلة التعويضية؟

Answer: Neural, hormonal, chemical.

عصبية، هرمونية، كيميائية: الإجابة

Clinical Manifestation / Assessment

Q6. Signs of poor tissue perfusion? (three)

علامات ضعف التروية؟ (ثلاثة)

Answer: Confusion, rapid breathing/low oxygen, low urine output.

ارتباك، تنفس سريع/نقص أكسجين، قلة البول: الإجابة

Q7. Severe complications of shock? (two)

مضاعفات خطيرة؟ (اثنين)

Answer: ARDS, DIC.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، تخثر منتشر: الإجابة.

Management / Goals

Q8. Two key goals in shock treatment?

هدفين رئيسيين لعلاج الصدمة؟

Answer: Preserve tissue perfusion, ensure oxygen.

الحفاظ على تدفق الدم، ضمان الأكسجين: الإجابة.

Q9. Two vasopressors in distributive shock?

مثبطان للأوعية الدموية في الصدمة التوزيعية؟

Answer: Dopamine, Norepinephrine.

دوبامين، نورإبينفرين: الإجابة.



Module 11: Triage

Definition

Q1. What is triage in ED?

ما هو الترياج في الطوارئ؟

Answer: Sorting patients by severity.

تصنيف المرضى حسب خطورة الحالة: الإجابة.

Goals

Q2. Two main goals of triage?

هدفان رئيسيان للترياج؟

Answer: Identify urgent cases, prioritize care.

تحديد الحالات العاجلة، ترتيب الأولويات: الإجابة.

Classification / Types

Q3. Emergent category examples and timing?

أمثلة الفئة الطارئة ووقت العلاج؟

Answer: Cardiac arrest, airway obstruction, severe bleeding; treat immediately or within 15–30 min.

توقف القلب، انسداد التنفس، نزيف شديد؛ العلاج فوراً أو خلال 15–30 دقيقة: الإجابة

Q4. Urgent category definition and max wait?

تعريف الفئة العاجلة وأقصى وقت انتظار؟

Answer: Serious but not immediately life-threatening; wait up to 2 hours.

حالات خطيرة لكنها ليست مهددة للحياة فوراً؛ الانتظار حتى ساعتين: الإجابة

Q5. Green vs Black tag in mass casualty?

الوسم الأخضر مقابل الأسود في الكوارث؟

Answer: Green: minor injuries, wait; Black: deceased/unable to survive.

أخضر: إصابات بسيطة، انتظر؛ أسود: متوفى/لا يمكن النجاة: الإجابة

Q6. Comprehensive triage system differences?

ما الفرق في النظام الشامل؟

Answer: More data collected, protocols for procedures.

جمع بيانات أكثر، بروتوكولات للإجراءات: الإجابة

Assessment

Q7. Level 2 reassessment frequency?

كم مرة يعاد تقييم المستوى 2؟

Answer: Every 15 minutes.

كل 15 دقيقة: الإجابة

Definition

Q1. What is ventricular fibrillation (V-fib)?

ما هو الرجفان البطيني؟

Answer: Chaotic ventricular activity, no effective heartbeat.

نشاط بطيني فوضوي، لا يوجد نبض فعال: الإجابة

Causes

Q2. Cardiac conditions causing atrial flutter? (three)

ما الحالات التي تسبب رجفان أذيني؟ (ثلاثة)

Answer: CAD, cor-pulmonale, rheumatic heart disease.

، أمراض القلب الروماتيزمية cor-pulmonale أمراض الشرايين التاجية، الإجابة

Q3. Causes of V-fib? (three)

أسباب الرجفان البطيني؟ (ثلاثة)

Answer: MI, untreated VT, electric shock.

احتشاء، تسرع بطيني غير معالج، صدمة كهربائية: الإجابة

Diagnostic Test (ECG)

Q4. Sinus tachycardia?

تسرع الجيب؟

Answer: >100 bpm, regular rhythm.

نبضة/دقيقة، نظم منتظم >100: الإجابة

Q5. P wave in atrial flutter?

في رجفان الأذنين؟ P موجة

Answer: Replaced by saw-tooth waves.

تتحول لموجات منشارية: الإجابة

Q6. QRS in ventricular tachycardia?

في التسارع البطيني؟ QRS

Answer: Wide, bizarre, P wave absent.

. غائبة P واسعة وغريبة، موجة :الإجابة

Q7. ECG of V-fib?

في الرجفان البطيني؟ ECG

Answer: Irregular wavy line, no QRS.

. QRS خط غير منتظم ومتموج، لا يوجد :الإجابة

Clinical Manifestation

Q8. When is sinus bradycardia treated?

متى يعالج بطء الجيب؟

Answer: If symptomatic: low BP, dizziness, chest pain.

. إذا ظهرت أعراض: انخفاض ضغط، دوار، ألم صدر :الإجابة

Management

Q9. Goals for atrial flutter?

هدف العلاج؟

Answer: Convert to sinus rhythm, control rate.

. تحويل إلى نظم الجيب، التحكم في معدل ضربات القلب :الإجابة

Q10. Emergency for V-fib?

الإجراء الطارئ؟

Answer: CPR and defibrillation.

. الإنعاش القلبي الرئوي والصدمات الكهربائية :الإجابة